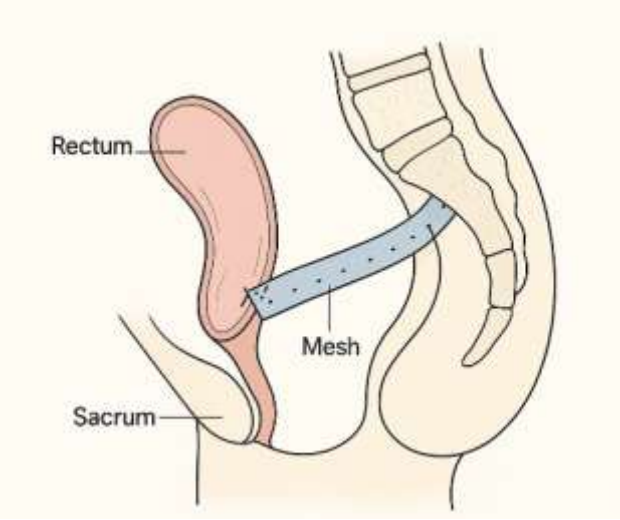
RECTOPEXIA

Mª Elisa de Castro Peraza, María Pérez López, Judith Reguera Cabrera, Mª Elba Palomares Ramos, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

El prolapso rectal es el descenso del recto por fallo de los mecanismos de sostén del suelo pélvico, de modo que el recto se invagina y puede llegar a exteriorizarse a través del ano. Puede presentarse como prolapso externo (protrusión completa visible) o como prolapso interno, asociado a rectocele u otras alteraciones del compartimento posterior, y con síntomas de masa, incontinencia, urgencia o estreñimiento obstructivo. El tratamiento es quirúrgico y busca restaurar la anatomía y mejorar la función, fijando el recto a una posición estable y evitando la lesión nerviosa pélvica. Entre los abordajes abdominales mínimamente invasivos, una técnica ampliamente utilizada es la rectopexia anterior o ventral con malla. En ella se realiza disección solo por la cara anterior del recto a través del tabique rectovaginal/rectovesical hasta el suelo pélvico, sin movilización posterior extensa, lo que contribuye a preservar la inervación autonómica y reducir el riesgo de estreñimiento postoperatorio.

Tras la disección, se coloca una malla longitudinal sobre la cara anterior del recto, que se fija con suturas al recto y posteriormente al promontorio sacro, que finalmente se reperitoniza. Pueden emplearse mallas sintéticas o biológicas; la elección depende del perfil de la paciente, los riesgos individuales y la escuela,



ya que ambas opciones muestran buenos resultados funcionales con baja recidiva, manteniéndose la vigilancia sobre posibles complicaciones relacionadas con la malla

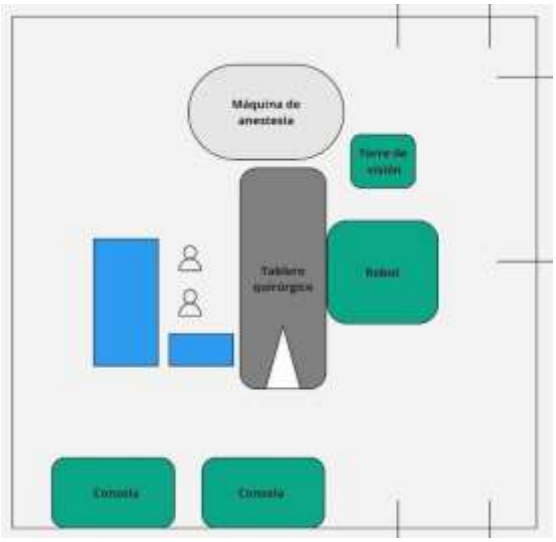
POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

- Decúbito supino
- Piernas en perneras (especialmente si es mujer y es preciso movilizar vagina)
- Brazos alineados con el cuerpo



POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

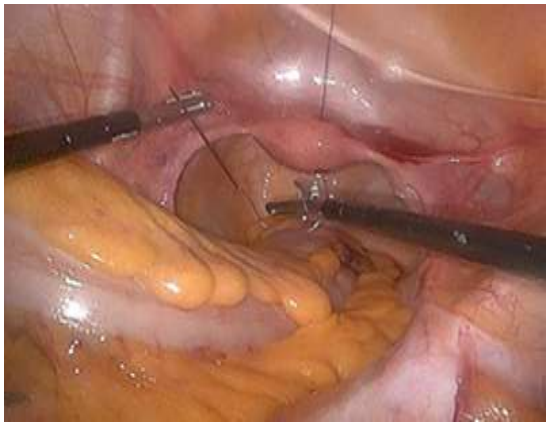
- Anatomía: abdominal inferior
- Lado: izquierda del paciente
  - Brazo 1: TipUp
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Optica 30
  - Brazo 4: tijera
- Tablero quirúrgico
  - Trendelemburg 20º
  - Lateral derecho 10º

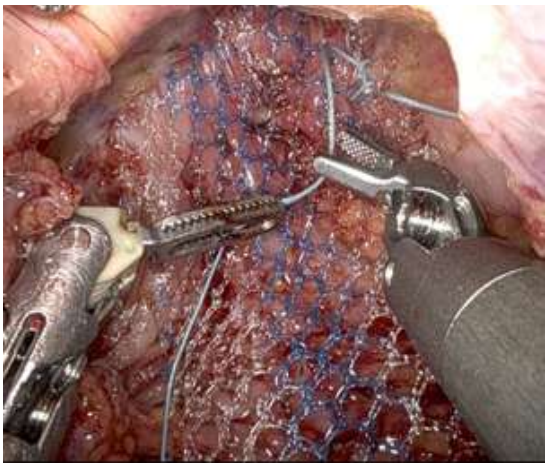


TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Se realiza sondaje vesical para mantener la vejiga vacía (y además poder realizar control de la diuresis)
- Se proceda a la colocación del campo y de los trócares.
- Revisión del campo y liberación de adherencias.

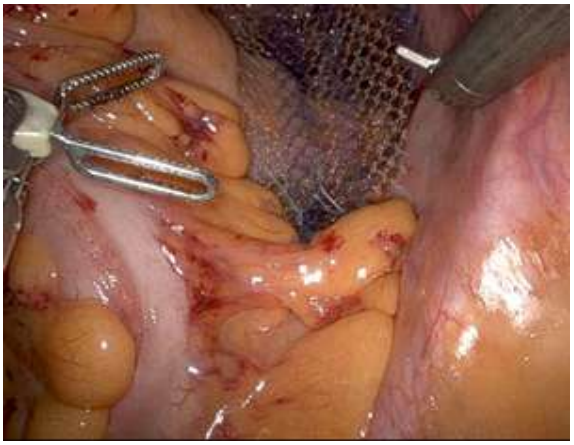
- Se suspende el útero con un punto de monofilamento de aguja recta,
- Se ancla la malla al recto (en su parte anterior) y con los primeros puntos se incluyen también parte de la musculatura del elevador del ano. Los primeros puntos se suturan a la altura del mismo suelo de la pelvis.

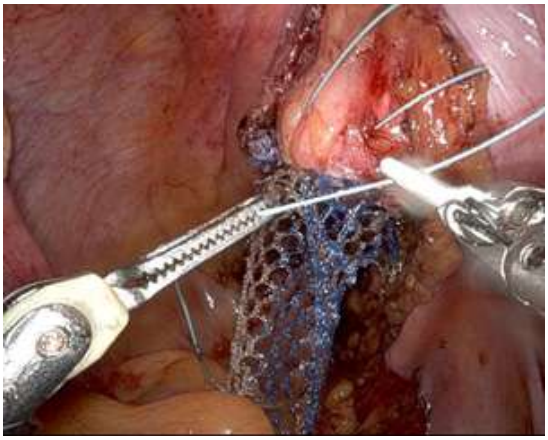




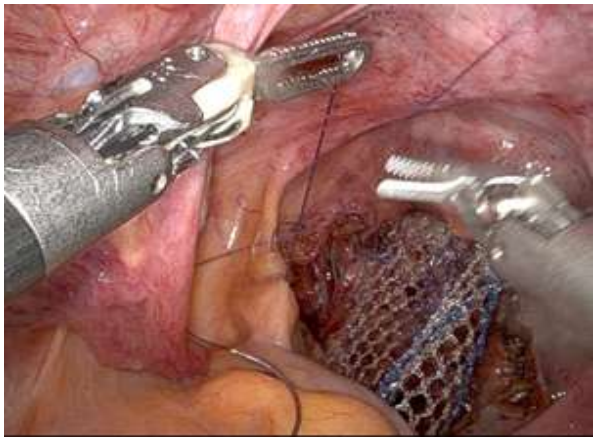


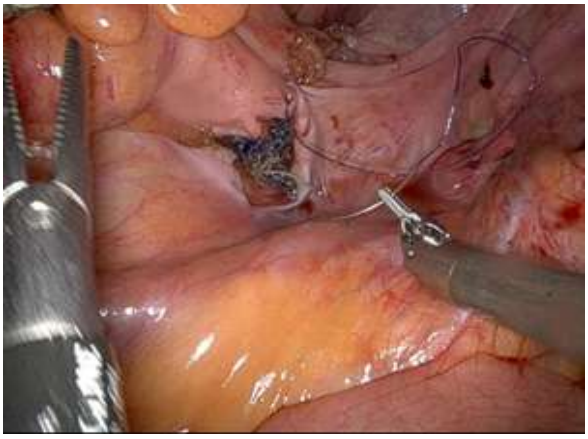
- Otro de los puntos de sutura es anclar la malla al promontorio.
- Después se ancla a la cúpula vaginal también con un punto.





- Se sutura uno de los laterales de la malla contribuyendo a la pexia.
- Se cierra el plano peritoneal con V-loc 3/0 y aguja grande, cubriendo toda la malla.





NOTAS

- Se usa malla de tipo Optilene y pegamento de tipo Histoacryl. Ambos suelen estar en armarios con acceso restringido (armario inteligente) y se suelen facturar nominalmente al paciente (habitualmente con vale preformado).
- Una alternativa frecuente es suturar la malla con Tricron de 2/0 con aguja de 26mm cortada a 12cm.
- En caso de deserosamiento se da un punto de vicryl 3/0.

BIBLIOGRAFÍA

1. Zubieta-O'Farrill G, Ramírez-Ramírez M, Villanueva-Sáenz E. Procedimiento de Frykman-Goldberg asistido por robot. Reporte de caso. Cirugía y Cirujanos. 2017;85(S1):84-88
2. Bordeianou L, Paquette I, Johnson E, Holubar SD, Gaertner W, Feingold DL, et al. Clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse. Dis Colon Rectum. 2017;60(11):1121-1131. doi:10.1097/DCR.0000000000000889.
3. D'Hoore A, Penninckx F. Laparoscopic ventral recto(colpo)pexy for rectal prolapse: surgical technique and outcome for 109 patients. Surg Endosc. 2006;20(12):1919-1923. doi:10.1007/s00464-005-0485-y.
4. Perry WRG, Christensen P, Collinson RJ, Cornish JA, D'Hoore A, Gurland BH, et al; Ventral Rectopexy Working Group. Ventral rectopexy: an international expert panel consensus and review of contemporary literature. Dis Colon Rectum. 2025;68(5):593-607. doi:10.1097/DCR.0000000000003656.
5. Grossi U, Ascanelli S, de'Angelis N, Sinatti E, D'Ovidio A, Schena CA, et al. Scoping review of indications for robotic ventral mesh rectopexy: addressing variability in patient selection. Int J Colorectal Dis. 2025;40(1):102. doi:10.1007/s00384-025-04893-y.
6. Barra M, Trilling B, Mastronicola G, Sage PY, Roudier A, Foote A, et al. Long-term outcome of laparoscopic ventral rectopexy for full-thickness rectal prolapse: the PEXITY study. Tech Coloproctol. 2025;29:68. doi:10.1007/s10151-024-03104-0.